Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 4

2.3 Жалобы и анамнез 4

2.4 Физикальное обследование 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Передняя риноскопия 5

3.3 Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух 5

3.4 Кожные пробы 6

3.5 Специфические IgE в сыворотке крови 6

3.6 Общий IgE 6

3.7 Общий (клинический) анализ крови 7

3.8 Цитологическое исследование смывов из полости носа 7

3.9 Рентгенография околоносовых пазух 7

3.10 Компьютерная томография околоносовых пазух 7

3.11 Спирометрия с бронхолитиком 7

3.12 Электрокардиография 7

3.13 Дифференциальная диагностика 8

4. Лечение 8

4.1 Ступенчатая терапия 8

4.2 Системные антигистаминные препараты 9
4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды 10
4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты 10
4.5 Монтелукаст и кромоглициевая кислота 11
4.6 Сосудосуживающие препараты 11
4.7 Тяжёлое течение 12
4.8 Немедикаментозное лечение 12
4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия 13
4.10 Хирургическое лечение 13
4.11 Нетрадиционные методы 13
5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации 13
5.1 Возрастные ограничения 13
5.2 Беременность и лактация 14
6. Контроль лечения 14
7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 15
8. Источник и актуальность 15
8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 16

1. Основные положения

- Диагноз аллергического ринита:

  Обязательные критерии

  1. **не менее двух** из четырёх симптомов, беспокоящих ежедневно **не менее часа**: заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу;
  2. связь симптомов с аллергеном;
  3. положительные результаты аллергологического обследования.
- Лечение ступенчатое:
  1. первая ступень: один препарат: антигистаминный внутрь или интраназально, кромоглициевая кислота или монтелукаст;
  2. вторая ступень: один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид;
  3. третья ступень: интраназальный глюкокортикостероид и один или несколько препаратов первой ступени;
  4. четвёртая ступень: омализумаб, решение о котором принимает только специалист.
- Интраназальные глюкокортикостероиды превосходят по эффективности антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, особенно при выраженной заложенности носа.
- Сосудосуживающие препараты допустимы только при обострении с выраженной заложенностью носа и только коротким курсом, **3–7 дней**.
- Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения.
- Лечение, как правило, амбулаторное.

  Показания к госпитализации

  1. крайне тяжёлое или осложнённое течение;
  2. у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа;
  3. плановое проведение ускоренного курса АСИТ.
- Хирургическое лечение показано только при сопутствующей патологии. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит является IgE-опосредованным воспалительным заболеванием слизистой оболочки носа, развивающимся под действием аллергенов. Для него характерны **не менее двух** симптомов, проявляющихся ежедневно **в течение часа и более**:

1. заложенность носа;
2. ринорея;
3. чихание;
4. зуд в полости носа.

2.2 Классификация

По этиологическому фактору

1. сезонный;
2. круглогодичный (бытовой);
3. профессиональный.

По течению

1. интермиттирующий: симптомы беспокоят **менее 4 дней в неделю** или **менее 4 недель в году**;
2. персистирующий: симптомы сохраняются **более 4 дней в неделю** и **более 4 недель в году**.

По тяжести

1. лёгкое течение: симптомы не нарушают сон и повседневную активность;
2. среднетяжёлое течение: симптомы препятствуют работе, учёбе, занятиям спортом и нарушают сон;
3. тяжёлое течение: без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать.

Кроме того, выделяют периоды обострения и ремиссии.

В формулировке диагноза указываются аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельной формой является локальный аллергический ринит. Для него характерны типичные симптомы с чёткой связью с аллергеном при отрицательных результатах кожных проб и исследования специфических IgE в крови. Определение специфических IgE в носовом секрете в России не проводится, назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. заложенность носа с дыханием через рот, сопением, храпом и изменением голоса;
2. водянистые выделения из носа;
3. чихание, нередко приступообразное, чаще в утренние часы;
4. зуд, реже жжение в носу, в ряде случаев зуд нёба и глотки;
5. на поздних стадиях снижение обоняния.

Характерен «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью), вследствие которого формируется поперечная носовая складка.

У каждого пациента с подозрением на аллергический ринит подробно собирают жалобы и анамнез.

Ведущие симптомы

1. круглогодичная форма: заложенность носа со слизистыми выделениями;
2. сезонная форма: приступы чихания, зуд и ринорея.

Уточняют

1. связь симптомов с аллергеном;
2. аллергические заболевания у пациента и его кровных родственников.

Обильные выделения и нарушение проходимости слуховых труб могут сопровождаться раздражением и отёком кожи над верхней губой и в области крыльев носа, носовыми кровотечениями после сморкания, болью в горле и покашливанием, болью и треском в ушах при глотании, снижением слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром, представляющий собой перекрёстную непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Его проявления варьируют от зуда в полости рта до анафилаксии.

2.4 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей, общий осмотр и аускультацию для выявления бронхиальной астмы, конъюнктивита и атопического дерматита.

Характерные признаки

1. затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот;
2. тёмные круги под глазами;
3. мацерация кожи над верхней губой;
4. отёчность лица.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. характерные жалобы: **не менее двух** симптомов из четырёх, ежедневно **не менее часа**;
2. данные анамнеза о связи с аллергеном или о других аллергических заболеваниях;
3. положительные результаты аллергологического обследования.

Задачи оториноларинголога

1. риноскопия и эндоскопическое исследование;
2. дифференциальная диагностика;
3. выявление осложнений и анатомических нарушений;
4. определение показаний к хирургическому лечению.

Задачи аллерголога-иммунолога

1. кожные и провокационные тесты и оценка их результатов;
2. исключение бронхиальной астмы;
3. решение вопроса об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.2 Передняя риноскопия

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. отёк носовых раковин;
2. обильный водянистый секрет;
3. слизистая оболочка ярко-красная в период обострения сезонного ринита;
4. слизистая оболочка цианотичная или серая при круглогодичном рините, в ряде случаев пятнистая («мраморная», симптом Воячека);
5. полипы.

3.3 Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность стандартной терапии;
2. осложнённое течение ринита.

Проба с сосудосуживающим средством позволяет оценить обратимость назальной обструкции.

3.4 Кожные пробы

Prick-тесты или скарификационные пробы при отсутствии противопоказаний.

Показания

1. подтверждение аллергической природы ринита;
2. выявление причинно-значимых аллергенов;
3. решение вопроса об АСИТ.

Пробы проводят в аллергологическом кабинете.

На результат влияют

1. возраст **младше 5 и старше 60 лет**;
2. приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов;
3. дермографизм: ложноположительный результат;
4. недавно перенесённая острая аллергическая реакция: ложноотрицательный результат.

Накануне и в день постановки теста антигистаминные препараты системного действия не принимают.

Пробы не проводят

1. при выраженном обострении заболевания, например в сезон пыления причинных растений;
2. при повреждении кожи обоих предплечий и спины;
3. при невозможности отменить антигистаминные препараты системного действия;
4. во время беременности и грудного вскармливания.

3.5 Специфические IgE в сыворотке крови

Показания

1. кожные пробы противопоказаны или невозможны;
2. результат кожных проб сомнителен;
3. результат кожных проб расходится с данными анамнеза.

Диагностические признаки

При использовании метода ImmunoCAP результат считается положительным при значении **более 0,70 kU/l**.

Молекулярная (компонентная) диагностика всем пациентам не показана.

Показания

1. расхождение данных анамнеза и результатов кожных проб и специфических IgE;
2. неэффективность АСИТ;
3. назначение АСИТ рекомбинантными аллергенами.

При подозрении на появление новой клинически значимой сенсибилизации исследование можно повторить в течение года.

Назальный провокационный тест с аллергенами выполняется только взрослым и только аллергологом-иммунологом в аллергологическом кабинете или стационаре.

Показания

1. расхождение данных анамнеза и результатов других методов диагностики;
2. множественная сенсибилизация, когда для АСИТ нужно выбрать клинически значимый аллерген.

3.6 Общий IgE

Для диагностики аллергического ринита исследование общего IgE нецелесообразно, поскольку не несёт необходимой диагностической информации.

Показания

1. только перед назначением омализумаба (**с 12 лет**, при тяжёлом течении): по уровню общего IgE рассчитывают дозу препарата.

3.7 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения;
2. подготовка к АСИТ.

Диагностические признаки

1. содержание эозинофилов;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево служит поводом для поиска инфекции, прежде всего острого риносинусита.

3.8 Цитологическое исследование смывов из полости носа

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения.

Диагностические признаки

1. эозинофилия носового секрета **10% и более**.

3.9 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. симптомы риносинусита: гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, повышение температуры тела;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

3.10 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность лечения;
2. выраженная и длительная назальная обструкция;
3. стойкая аносмия;
4. отрицательные результаты аллергологического обследования, прежде всего при подозрении на полипозный риносинусит.

3.11 Спирометрия с бронхолитиком

Показания

1. кашель, свистящее дыхание, одышка;
2. подготовка к АСИТ: выявление скрытого бронхоспазма.

Снижение ОФВ1 **менее 70%** от должных величин является одним из противопоказаний к АСИТ.

3.12 Электрокардиография

Показания

1. подготовка к инъекционной АСИТ.

3.13 Дифференциальная диагностика

Заболевания для дифференциальной диагностики

1. инфекционный ринит;
2. аномалии внутриносовых структур;
3. аденоиды у детей;
4. полипозный риносинусит;
5. эозинофильный ринит;
6. лекарственный ринит: на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, резерпина, длительного применения деконгестантов;
7. гормональный ринит: беременность, пубертатный период, менструальный цикл, приём контрацептивов, акромегалия, гипотиреоз;
8. профессиональный ринит;
9. атрофический ринит пожилых;
10. пищевой и алкогольный ринит;
11. идиопатический ринит;
12. первичная цилиарная дискинезия и муковисцидоз.

---

4. Лечение

Целью лечения является полный контроль симптомов. При продолжающемся контакте с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями достижимо лишь уменьшение выраженности симптомов.

4.1 Ступенчатая терапия

На любой ступени

1. исключение контакта с аллергеном;
2. хирургическое лечение сопутствующей патологии при наличии показаний;
3. рассмотрение вопроса об АСИТ.

Первая ступень: один из препаратов

1. антигистаминный препарат без седативного эффекта внутрь;
2. антигистаминный препарат интраназально;
3. кромоглициевая кислота интраназально;
4. монтелукаст.

Вторая ступень: один из препаратов

1. интраназальный глюкокортикостероид (предпочтительно);
2. антигистаминный препарат внутрь или интраназально;
3. монтелукаст.

Третья ступень: интраназальный глюкокортикостероид в сочетании с одним или несколькими препаратами

1. антигистаминный препарат внутрь;
2. антигистаминный препарат интраназально;
3. монтелукаст.

Четвёртая ступень

Омализумаб при тяжёлом течении, **с 12 лет**. Назначается только специалистом.

Препараты скорой помощи на любой ступени: сосудосуживающие препараты коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Перед переходом на ступень выше следует повторно оценить правильность диагноза, приверженность лечению, наличие сопутствующих заболеваний и анатомических аномалий.

4.2 Системные антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты без седативного эффекта рекомендованы всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность носа. Цетиризин в высоких дозах чаще других препаратов вызывает сонливость.

Назначение седативных антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендуется, поскольку они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к развитию апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	1. взрослые и дети с 12 лет: 5 мг 1 раз в сутки; 2. дети 6–11 лет: 2,5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 1–5 лет: 1,25 мг 1 раз в сутки; 4. дети 6–12 месяцев: 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 5 мг 1 раз в сутки; 2. дети 2–6 лет: 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 10 мг 1 раз в сутки; 2. дети 2–12 лет с массой тела до 30 кг: 5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 2–12 лет с массой тела более 30 кг: 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 120 мг 1 раз в сутки; 2. дети 6–11 лет: 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 5–10 мг 1 раз в сутки; 2. дети 2–6 лет: 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 1–2 лет: 2,5 мг 2 раза в сутки; 4. дети 6–12 месяцев: 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 10–20 мг 1 раз в сутки; 2. лекарственная форма: имеется форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение, особенно при выраженной заложенности носа.

По эффективности превосходят антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, уменьшают и глазные симптомы.

Нежелательные явления

1. сухость слизистой оболочки;
2. носовые кровотечения;
3. редко перфорация носовой перегородки.

Пациента обучают правильной технике введения спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости до 4 доз; 2. поддерживающая терапия: 1 доза 1 раз в сутки; 3. дети 2–12 лет: 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки; 2. поддерживающая терапия: 1 доза 1 раз в сутки; 3. дети 2–12 лет: 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки; 2. поддерживающая терапия: 1 доза 1 раз в сутки; 3. дети 4–12 лет: 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	1. взрослые и дети старше 6 лет: 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки; 2. поддерживающая терапия: 200 мкг в сутки; 3. длительность: не более 3 месяцев.
Беклометазон	1. взрослые и дети старше 6 лет: 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки (максимальная доза); 2. поддерживающая терапия: 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты

Интраназальные антигистаминные препараты быстро, **в течение 30 минут**, уменьшают выраженность симптомов. Их применяют в монотерапии или в сочетании с другими препаратами; возможна сухость слизистой оболочки носа.

При необходимости одновременного интраназального применения антигистаминного препарата и глюкокортикостероида целесообразно назначение одного комбинированного спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки; 2. с 12 лет: при необходимости 2 дозы; 3. длительность: не более 6 месяцев.
Левокабастин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза; 2. длительность: при отсутствии эффекта в течение 3 дней препарат отменяется.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин и флутиказон	1. взрослые и дети старше 12 лет: 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	1. взрослые с 18 лет: 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки; 2. длительность: 2 недели.
Мометазон и олопатадин	1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина); 2. дети 6–11 лет, только при сезонном рините: 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст может назначаться при любой степени тяжести, в монотерапии или в сочетании с другими препаратами, однако по эффективности он уступает интраназальным глюкокортикостероидам.

При сопутствующей бронхиальной астме монелукаст позволяет контролировать оба заболевания. Курс лечения **от 1 до 3 месяцев и более**; согласно инструкции, ограничений по длительности применения нет.

При необходимости назначения и антигистаминного препарата внутрь, и монелукаста возможно применение комбинированной таблетки левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту интраназально используют при лёгком течении. Препарат безопасен, однако по эффективности уступает антигистаминным препаратам, монелукасту и интраназальным глюкокортикостероидам.

Препарат	Доза
Монелукаст	1. взрослые и дети старше 15 лет: 10 мг 1 раз в сутки; 2. дети 6–15 лет: 5 мг 1 раз в сутки; 3. дети 2–6 лет: 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	1. взрослые и дети старше 15 лет: 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	1. взрослые и дети старше 5 лет: 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз; 2. после достижения эффекта: возможно применение только при контакте с аллергеном; 3. длительность: 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью носа сосудосуживающие препараты применяют коротким курсом, **3–7 дней**.

Длительное применение не рекомендуется: **после 10 дней** развиваются привыкание, отёк слизистой оболочки и медикаментозный ринит.

При необходимости интраназального применения и антигистаминного, и сосудосуживающего препарата возможно назначение комбинации диметиндена с фенилэфрином, не более 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки; 2. дети 1–6 лет: 1–2 капли 0,025% раствора 2–3 раза в сутки; 3. дети от 5 недель до года: 1–2 капли 0,01% раствора 2–3 раза в сутки; 4. дети до 4 недель: 1 капля 0,01% раствора 2–3 раза в сутки; 5. длительность: 3–4 дня.
Ксилометазолин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки; 2. дети 2–6 лет: 1 доза 0,05% раствора 1–2 раза в сутки; 3. длительность: не более 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	1. взрослые и дети старше 6 лет: 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки; 2. дети 1–6 лет: только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или неэффективности третьей ступени возможно назначение короткого курса глюкокортикоидов внутрь.

Глюкокортикоиды системного действия: условия применения

1. терапия четвёртой линии или лечение тяжёлого обострения;
2. доза преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирается индивидуально;
3. преднизолон в таблетках противопоказан детям **до 3 лет**.

Введение растворов и депо-форм глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: риск тяжёлых осложнений вплоть до слепоты.

Назначение депо-форм глюкокортикоидов не рекомендуется в связи с быстрым развитием побочных эффектов, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Назначение омализумаба рассматривается **с 12 лет** при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении в случае неэффективности третьей ступени.

Решение о назначении таргетной терапии принимает врачебный консилиум.
Препарат вводится подкожно каждые 2 или 4 недели в дозе от 75 до 600 мг в соответствии с таблицей дозирования. При сезонном рините у пациентов с тяжёлым течением, которые своевременно не прошли АСИТ, введение начинается не менее чем за неделю до начала пыления и продолжается до его окончания.
Эффект омализумаба развивается в течение 3–7 дней; при коротком сезоне пыления (1 месяц) полного контроля симптомов можно достичь 1–2 инъекциями.

4.8 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение контакта облегчает течение заболевания и снижает потребность в лекарственных препаратах.

Рекомендуется применение изотонических солевых растворов для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением интраназального глюкокортикостероида полость носа целесообразно промыть: это улучшает контакт препарата со слизистой оболочкой и снижает частоту сухости и носовых кровотечений.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

Проведение АСИТ рассматривается у всех пациентов в период ремиссии, в том числе медикаментозной. Метод уменьшает выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, предупреждает развитие бронхиальной астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяются аллергологом-иммунологом, которым и назначается АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают только при сопутствующей патологии; показания определяются оториноларингологом по данным эндоскопического и рентгенологического исследования. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

В сезон цветения растений, к пыльце которых есть аллергия, не рекомендуется и профилактическая вакцинация. Её проводят до начала сезона цветения или откладывают до его завершения.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатия, фитотерапия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапия не рекомендуются в связи с отсутствием доказательств их эффективности.

Иглоукалывание может рассматриваться в составе комплексной терапии.

---

5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации

5.1 Возрастные ограничения

Интраназальные глюкокортикостероиды у детей

1. мометазон, флутиказона фуроат: **с 2 лет**;
2. флутиказона пропионат: **с 4 лет**;
3. беклометазон, будесонид: **с 6 лет**.

Антигистаминные препараты у детей

1. цетиризин, дезлоратадин: **с 6 месяцев**;
2. лоратадин: **с 2 лет**;
3. первого поколения (хлоропирамин, диметинден): **с 1 месяца**.

По достижении ребёнком соответствующего возраста предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст у детей

1. 4 мг: **с 2 лет**;
2. 5 мг: **с 6 лет**.

У детей особое внимание уделяют элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа изотоническими солевыми растворами или применению барьерных средств на основе микрокристаллической целлюлозы, сводя медикаментозную нагрузку к минимуму.

У детей интраназальные глюкокортикостероиды уменьшают не только назальную обструкцию и другие симптомы ринита, но и гипертрофию аденоидов, а следовательно, и потребность в хирургическом лечении.

Кромоглициевая кислота безопасна и эффективна в отношении зуда в носу, чихания и ринореи, однако её применение ограничено высокой кратностью введения, меньшей эффективностью по сравнению с интраназальными глюкокортикостероидами и отсутствием эффекта в отношении заложенности носа.

Согласно инструкциям к препаратам, АСИТ возможна **с 5 лет**.

Детям интраназальные глюкокортикостероиды применяют в минимальной эффективной дозе; при длительном применении необходим контроль роста.

Предпочтительно ограничить применение препаратов с высокой биодоступностью: будесонида (30–40%) и беклометазона (40–50%). Биодоступность дексаметазона превышает 80%, что следует учитывать, поскольку он входит в состав многих комбинированных капель.

5.2 Беременность и лактация

У беременных необходимо учитывать возможность ринита беременных, который характеризуется заложенностью носа без признаков инфекции и аллергии и полностью регрессирует **в течение 2 недель** после родов. Выявленная сенсибилизация свидетельствует в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и лактации не выполняют; для аллергологического обследования исследуется уровень специфических IgE в сыворотке крови.

Предпочтение отдаётся элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа. К лекарственной терапии переходят при их недостаточной эффективности с учётом рисков для матери и ребёнка.

Для лоратадина, цетиризина и будесонида доказательства риска для человека отсутствуют (категория B по классификации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, FDA).

В первом триместре назначения лекарственных препаратов по возможности следует избегать, за исключением случаев жизненной необходимости.

В период лактации предпочтительно ограничиться местными средствами с минимальной системной биодоступностью. Все системные препараты проникают в грудное молоко, поэтому при необходимости их назначения следует рассмотреть вопрос о прекращении грудного вскармливания.

---

6. Контроль лечения

Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения. Методика оценки приведена ниже.

Визуальная аналоговая шкала представляет собой линию длиной 10 см, на которой пациент отмечает выраженность беспокоящих его симптомов. При отметке **от 0 до 50 мм** ринит считается контролируемым, при отметке **50 мм и более** неконтролируемым.

Подростки и взрослые, ВАШ 50 мм и более (ринит не контролируется): пошаговый алгоритм

1. антигистаминные препараты **на 2–4 недели**;
2. контроль достигнут: лечение по потребности, рассмотреть АСИТ;
3. контроля нет: добавить интраназальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё **на 2–4 недели**;
4. контроль не достигнут и в этом случае: пересмотреть диагноз, искать сопутствующую патологию, рассмотреть АСИТ и хирургическое лечение.

Если сохраняются глазные симптомы, добавляют препараты для лечения аллергического конъюнктивита.

Ринит контролируемый, если за последние 4 недели

1. симптомы отсутствовали;
2. не нарушались сон и дневная активность;
3. результат теста «дыхание с закрытым ртом» нормальный.

Любое отклонение, в том числе учащение потребности в препаратах скорой помощи, означает потерю контроля; возможен переход на ступень выше.

Для проведения теста пациенту предлагается закрыть рот и в течение 30 секунд дышать только носом.

Обострение сопутствующих заболеваний (бронхиальной астмы, синусита, синдрома ночного апноэ) может нарушить контроль ринита.

Решение о снижении объёма терапии принимают, оценивая бессимптомный период на фоне предшествующего лечения за последние **4 недели**.

При ведении дневника симптомов (шкала TNSS, суммарная оценка назальных симптомов) пациент ежедневно оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов; суммарный балл составляет от 0 до 12. Врач рассчитывает среднее значение за 7 дней. Дневник ведётся в период обострения и для оценки эффективности АСИТ.

Отдельно оценивается медикаментозная нагрузка: приём только антигистаминных препаратов соответствует 1 баллу, интраназальных глюкокортикостероидов 2 баллам, системных глюкокортикоидов 3 баллам.

---

7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Каждому пациенту или его представителям следует разъяснить суть заболевания, составить индивидуальный план лечения и обучить навыкам самостоятельного контроля заболевания.

Пациенты подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые **не реже одного раза в год**, дети **не реже двух раз в год**. Наблюдение осуществляется пожизненно или до достижения стойкой ремиссии длительностью **3 года и более**.

АСИТ применяется и для вторичной профилактики: она позволяет предупредить развитие бронхиальной астмы, утяжеление течения ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации рекомендуется ограничить употребление перекрёстно реагирующих продуктов и растительных лекарственных средств.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. крайне тяжёлое или осложнённое течение;
2. у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа;
3. плановое проведение ускоренного курса АСИТ.

Критерии выписки

1. достижение контроля над симптомами, нормализация лабораторных показателей;
2. завершение курса АСИТ.

---

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года

Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная как «22.4 мкг»; эти значения следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», тогда как в оригинальном названии указано «untreated patients», то есть пациенты, не получавшие лечения.